Клинические рекомендации

Инородное тело в пищеварительном тракте

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**T18** — Инородное тело в пищеварительном тракте
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 17.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов"; Общероссийская общественная организация "Российское общество хирургов"; Общероссийская общественная организация содействия развитию лучевой диагностики и терапии "Российское общество рентгенологов и радиологов" ; Ассоциация "Эндоскопическое общество "РЭндО"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/710_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Физикальное обследование при поступлении 6

3.3 Лабораторные исследования: анализы крови 6

3.4 Рентгенография 6

3.5 Рентгеноскопия с контрастом 7

3.6 Компьютерная томография 7

3.7 Эндоскопия 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 7

4.1 Сроки эндоскопии 7

4.2 Консервативное ведение 8

4.3 Эндоскопическое лечение 8

4.4 После удаления 10

4.5 Медикаментозная терапия 11

4.6 Хирургическое лечение 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
5.1 Организация помощи и госпитализация 12
5.2 Реабилитация и профилактика 13
6. Источник и актуальность 13
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Инородным телом пищеварительного тракта называют любой объект, проглоченный, введённый в его просвет или образовавшийся в нём, который не может служить пищей.
- При поступлении показан осмотр оториноларинголога для исключения инородного тела полости рта и глотки и осмотр хирурга для выявления признаков перфорации и других осложнений.
- Диагноз устанавливается при обнаружении инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции.
- При батарейке, остроконечном предмете или полной обструкции в пищеводе эндоскопическое удаление выполняется экстренно: **лучше в течение 2 часов, не позднее 6**. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно, **в течение 24 часов**.
- Дисковую батарейку у ребёнка, в том числе находящуюся в желудке, удаляют независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**.
- Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, не вызывает симптомов, тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).
- Консервативное ведение при батарейках и магнитах противопоказано; эндоскопическое удаление контейнеров с наркотиками не рекомендуется.
- Пациентов госпитализируют в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в отделение реанимации и интенсивной терапии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Инородное тело пищеварительного тракта — объект органического, неорганического или искусственного происхождения, случайно или намеренно проглоченный, введённый в просвет пищеварительного тракта или образовавшийся в организме, который по составу и (или) расположению не может служить пищей.

Условно инородные тела — пища, желчные камни, паразиты, становящиеся инородным телом при определённых обстоятельствах: вклинение пищевого комка в зону сужения пищевода, миграция желчного камня в просвет кишки, конгломерат паразитов.

Инородные тела по воздействию на стенку

Вид	Определение
Инертные	без выраженного патологического воздействия на стенку: монеты, мелкие игрушки, клипсы, стеклянные и металлические шарики
Механически активные	механическое повреждение стенки: иголки, булавки, саморезы, проволока
Физически активные	выраженное физическое, компрессионное воздействие: магниты
Химически активные	химические и термические ожоги вплоть до перфорации: дисковые батарейки таблеточного типа
С комбинированным воздействием	механическое (обтурация, компрессия) и химическое воздействие: безоары, силикагелевые шарики

Признак Турнера — ощущение инородного тела в гортаноглотке или пищеводе даже после его прохождения в желудок.

2.2 Этиология

У детей инородные тела пищеварительного тракта встречаются чаще, чем у взрослых; пик заболеваемости приходится на возраст от 6 месяцев до 6 лет. Наиболее распространены у детей монеты: самостоятельно через пищевод они проходят у 30–60%.

Застрявшая в пищеводе дисковая батарейка является экстренной ситуацией, угрожающей жизни ребёнка: возможны трахеопищеводный и трахеоаортальный свищ, медиастинит, абсцесс шеи.

Взрослые проглатывают инородные тела случайно, а пациенты с психическими заболеваниями и отбывающие наказание — намеренно; «курьеры» проглатывают контейнеры с наркотиками. Отдельную группу составляют ятрогенные инородные тела (видеокапсулы, стенты, зубные протезы).

2.3 Классификация

1. по происхождению: истинные (проглоченные умышленно, случайно, незаметно; введённые через задний проход; оставленные при вмешательствах; попавшие при травме) и условно инородные тела (вклиненный пищевой комок; желчные камни, безоары, каловые камни; живые инородные тела);
2. по локализации: пищевод (68,4%), желудок (18,9%), тонкая кишка (7,1%), толстая кишка (3%), прямая кишка (2,6%).

1. по количеству: единичные, множественные;
2. по динамике: мигрирующие, свободнолежащие, фиксированные;
3. по величине: мелкие (**до 2–2,5 см в диаметре или до 5 см в длину**), средние (2,5–5 см или до 10 см), крупные (более 5 см или более 10 см);
4. по воздействию: инертные; потенциально агрессивные (контейнеры с наркотиками, хрупкие предметы); агрессивные, в том числе химически (батарейки), физически (магниты, ртуть), механически активные (остроконечные) и комбинированные (безоары, силикагель).

Рентгеноконтрастность инородных тел

Контрастность	Инородные тела
рентгеноконтрастные, хорошо видны на снимке	истинные рентгенопозитивные инородные тела непищевого происхождения, мясные кости
малоконтрастные и рентгенонегативные, как правило, не видны	пищевой комок, рыбьи и куриные кости, дерево, пластик, стекло, тонкие металлические предметы

Классификация Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии

Тип	Примеры
тупые	монета, пуговица, игрушка; батарейки, магниты
остроконечные	игла, зубочистка, кость, булавка, осколки стекла; фрагмент зубного протеза, лезвие
длинные	мягкие (струна, верёвка), твёрдые (зубная щётка, столовый прибор, отвёртка, ручка)
пищевые комки	с костями или без
другие	контейнеры с запрещёнными веществами

2.4 Клиническая картина

У детей зона глоточно-пищеводного перехода уже и длиннее, поэтому инородное тело чаще застревает в шейном отделе пищевода. Непищевые инородные тела составляют 75–90%, чаще возникает респираторный синдром.

Проявления у детей

1. кашель, одышка, свистящее дыхание, ложный круп;
2. гиперсаливация, слюнотечение, поперхивание, рвота;
3. дисфагия, одинофагия, отказ от еды, ощущение комка в горле.

У части детей симптомов нет до развития осложнений.

Инородное тело пищевода у взрослых (выраженная картина у 50–68%)

1. боль по ходу пищевода, в яремной ямке, затылке, спине, эпигастрии;
2. слюнотечение, невозможность проглотить твёрдую и жидкую пищу, дисфагия, срыгивание;
3. одышка; вынужденное положение при инородном теле в виде «якоря».

Вторичные проявления

1. лихорадка, обезвоживание, запах изо рта;
2. осиплость голоса;
3. инфильтрация мягких тканей шеи, подкожная эмфизема, пневмоторакс.

10% инородных тел пищевода бессимптомны; «мнимые» инородные тела — 10–15%.

Большинство инородных тел (80–90%) выходит самостоятельно; эндоскопическое удаление требуется в 10–20% случаев, хирургическое вмешательство — менее чем в 1%.

Клинические проявления инородных тел желудка и ДПК мало выражены: клинически проявляются только крупные, длинные и остроконечные предметы. При длительном нахождении инородного тела пролежень с последующей перфорацией стенки приводит к перитонеальным симптомам или забрюшинному инфильтрату.

Крупные инородные тела прямой кишки, особенно намеренно введённые у детей, вызывают тенезмы, боль в промежности и кровь в стуле. Отсутствие симптомов не служит поводом отказаться от обследования.

---

3. Диагностика

Диагноз подтверждается обнаружением инородного тела при рентгенологическом или эндоскопическом исследовании либо во время операции. На догоспитальном этапе и при поступлении диагноз основывается на анамнезе и данных осмотра.

3.1 Жалобы и анамнез

Тщательная оценка жалоб и детальный анамнез.

Необходимо выяснить

1. что проглочено (на снимке монета похожа на дисковую батарейку);
2. сколько прошло времени, когда последний раз ел и пил;
3. пытался ли пациент сам извлечь или «протолкнуть» инородное тело (сухой хлеб);
4. были ли попытки эндоскопического удаления;
5. были ли ранее такие эпизоды и установлен ли диагноз эозинофильного эзофагита, ГЭРБ, рубцовой стриктуры пищевода или ахалазии кардии;
6. у детей: имеются ли в анамнезе стенозы, ожоги пищевода или операции на нём.

У ребёнка с такой патологией дисфагия, слюнотечение, отказ от еды, поперхивание или апноэ при кормлении заставляют заподозрить инородное тело и являются показанием к эзофагоскопии.

Гиперсаливация и невозможность глотать жидкость свидетельствуют о полной непроходимости пищевода. Удушье, стридор и одышка могут быть следствием аспирации слюны или сдавления трахеи инородным телом.

3.2 Физикальное обследование при поступлении

Осмотр при поступлении

1. оториноларинголог: подтверждение или исключение инородного тела в полости рта и глотке;
2. хирург: признаки перфорации пищевода (подкожная эмфизема, отёк, инфильтрат шеи), осложнения со стороны желудка и кишечника;
3. аускультация лёгких: хрипы, признаки аспирации;
4. подозрение на инородное тело прямой кишки: пальцевое исследование.

Лихорадка и тахикардия настораживают в отношении осложнения. При длительно стоящем инородном теле пищевода и отсутствии торакального отделения пациента переводят в профильный стационар или вызывают специалиста.

3.3 Лабораторные исследования: анализы крови

При поступлении

1. общий анализ крови;
2. биохимический анализ крови: глюкоза, мочевина, креатинин, амилаза, билирубин, АЛТ, АСТ.

По показаниям

1. калий, натрий, тромбоциты;
2. АЧТВ, МНО, фибринолитическая активность;
3. группа крови и резус-фактор.

3.4 Рентгенография

При подозрении на рентгеноконтрастное инородное тело или если характер инородного тела неизвестен, выполняется неотложная рентгенография мягких тканей шеи, органов грудной клетки и брюшной полости.

Сначала выполняют снимок в прямой проекции; ложноотрицательные результаты достигают 47%, поэтому при отрицательном результате дополнительно выполняют боковую проекцию. Для шейного отдела пищевода выполняют снимок шеи в боковой и прямой проекции с приподнятой головой.

Детям с подозрением на проглатывание инородного тела, даже без симптомов, показана неотложная рентгенография шеи, грудной клетки и брюшной полости, по показаниям также таза, в 2 проекциях.

При застрявшем пищевом комке без костей и без признаков осложнений обзорная рентгенография, как правило, не рекомендуется: ложноотрицательные результаты достигают 87%.

3.5 Рентгеноскопия с контрастом

При подозрении на обтурацию или перфорацию пищевода, рентгенонегативном инородном теле, сомнениях в локализации выполняется рентгеноскопия глотки и пищевода с водорастворимым йодсодержащим контрастом. Исследование не должно задерживать эндоскопию.

Контраст дают малыми порциями. При нарушении глотания (инородное тело на уровне глоточно-пищеводного перехода, неврологические заболевания) йодсодержащий контраст не применяют из-за риска аспирации и отёка лёгких.

Применение бария сульфата не рекомендуется: он опасен аспирацией и затрудняет последующую эндоскопию.

3.6 Компьютерная томография

При клинической картине перфорации пищевода, флегмоны шеи, медиастинита и других осложнений выполняется КТ органов грудной и брюшной полости.

Рыбьи кости — частые инородные тела у взрослых, застревают в верхней части пищевода; чувствительность рентгенографии составляет 32%, КТ — 90–100%. У детей КТ выполняют при рентгенонегативных инородных телах. Свободный газ под диафрагмой при перфорации инородным телом — ненадёжный признак.

3.7 Эндоскопия

Перед эндоскопией анализируют клиническую картину и данные лучевых исследований, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Всем пациентам с подозрением на инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта показана ЭГДС, в том числе при отрицательном результате рентгенографии; она же является первым этапом лечебного вмешательства. У детей инородное тело пищевода удаляют **менее чем через 24 часа**.

При подозрении на инородное тело прямой или сигмовидной кишки выполняется ректороманоскопия.

3.8 Дифференциальная диагностика

Сходная клиническая картина наблюдается при

1. кандидозном, рефлюкс- и эозинофильном эзофагите;
2. ахалазии кардии;
3. после инсульта, в дебюте рассеянного склероза, БАС, миастении;
4. опухоли пищевода;
5. истерии и других заболеваниях нервной системы.

При интенсивной боли за грудиной необходимо исключить острый коронарный синдром, при инородном теле желудка и кишки — заболевания с картиной острого живота.

---

4. Лечение

4.1 Сроки эндоскопии

Сроки эндоскопического вмешательства: экстренно — лучше в течение 2 часов, не позднее 6; срочно — в течение 24 часов; отсроченно — в течение 72 часов

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
батарейка	экстренно	срочно

Инородное тело	Пищевод	Желудок, тонкая кишка
магнит	срочно	срочно
остроконечное	экстренно	срочно
тупое, менее 2–2,5 см	срочно	отсроченно
тупое, 2–2,5–5 см	срочно	отсроченно (в тексте КР — в течение 24–48 часов)
большое, более 5–6 см	срочно	срочно
дисковая батарейка у ребёнка (текст КР, раздел 3)	экстренно	лучше в течение 12 часов, не позднее 24 часов
пищевой комок	экстренно (срочно — без симптомов и полной обструкции)	—

4.2 Консервативное ведение

Наблюдение без извлечения допустимо, если инородное тело находится вне пищевода, симптомов нет, оно тупое, инертное и небольшое (**до 2–2,5 см в диаметре или 5 см в длину**).

После пищевода большинство инородных тел проходит ЖКТ за **4–6 дней**, редко — до 4 недель; через привратник не проходят предметы более 2–2,5 см, через изгиб ДПК — длиннее 5–6 см. Без симптомов при инородном теле желудка меньше этих размеров возможно амбулаторное наблюдение: пациента предупреждают о симптомах перфорации и непроходимости.

При наблюдении за небольшим тупым рентгеноконтрастным инородным телом проводится периодический рентгенологический контроль, при отсутствии симптомов еженедельно. Если инородное тело не вышло из желудка **за 3–4 недели**, его удаляют эндоскопически.

При контейнерах с наркотиками без симптомов необходимы пристальное наблюдение в стационаре, лаваж кишечника и рентгенологический контроль; эндоскопически контейнеры не удаляют.

При безоаре желудка сначала применяют 5–10% раствор пищевой соды или напитки с ортофосфорной кислотой, которые размягчают растительные безоары; их приём продолжают между сеансами эндоскопии.

Консервативное ведение противопоказано

1. магниты и батарейки;
2. остроконечные инородные тела;
3. безоары, силикагелевые шарики;
4. любые длительно стоящие инородные тела пищевода.

Магнит удаляют, даже если на снимке он один.

4.3 Эндоскопическое лечение

Перед удалением анализируют анамнез, клиническую картину, данные лучевых исследований и эндоскопическую картину, чтобы выбрать обезболивание, эндоскоп и инструменты.

Экстренное удаление (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**) показано при полной обструкции пищевода, остроконечных предметах и батарейках в пищеводе. Остальные инородные тела пищевода, в том числе магниты, удаляют срочно (**в течение 24 часов**).

Частота перфорации остроконечными предметами достигает 35%. Дисковая батарейка быстро повреждает пищевод: электрический ожог, утечка щелочи, пролежень. Риск тяжёлых осложнений при инородном теле в пищеводе **более 24 часов** выше в 14,1 раза.

Из желудка и проксимальной части ДПК у детей с симптомами остроконечные, крупные инородные тела, магниты и батарейки удаляют экстренно (**в первые 2 часа**); у взрослых, а также у детей без симптомов (магниты) — срочно (**в течение 24 часов**).

Сроки удаления инородных тел желудка

1. дисковые батарейки у детей независимо от симптомов, размера и количества: **лучше в течение 12 часов, не позднее 24**; после 12 часов риск осложнений возрастает в 4,5 раза;
2. инородные тела более 2–2,5 см: **в течение 24–48 часов** (в таблице 3 КР — отсроченно, в течение 72 часов);
3. тупое небольшое инородное тело, не покинувшее желудок **за 3–4 недели** (желательно не более 1 недели): эндоскопическое извлечение.

Цилиндрическую батарейку у ребёнка в пищеводе удаляют экстренно (**лучше в течение 2 часов, не позднее 6**), в других отделах пищеварительного тракта — как можно быстрее.

Крупные инородные тела прямой кишки удаляют экстренно, особенно у детей: под наркозом после девульсии ануса, зажимами Кохера.

Удаление выполняют под общим обезболиванием; у детей только под наркозом с интубацией трахеи (или внутривенно с сохранением спонтанного дыхания, глубокая седация). У взрослых нетравмоопасные инородные тела удаляют под внутривенной анестезией или седацией, при невозможности под местной анестезией.

Методом выбора является гибкая видеоэндоскопия: успех более 95%, осложнения 0–5%. Ригидную эзофагоскопию применяют только при инородном теле в верхней трети пищевода, которое не удаётся извлечь гибким эндоскопом, при перфорации в операционной перед дренированием средостения или если гибкой эндоскопии нет.

При длительно стоящем инородном теле или после прежних безуспешных попыток извлечения его удаляют в операционной с инсуффляцией углекислого газа.

Раскрытую булавку, которую нельзя безопасно извлечь из-за расположения под углом, проводят в желудок, разворачивают и извлекают острым концом дистально. Длинный предмет захватывают за кончик.

При остроконечных инородных телах используют защитные устройства: дистальный колпачок, конус, тубус (для инородных тел дистальнее пищевода длиной 45–60 см).

Специальные инструменты по типу инородного тела: щипцы «зуб крысы», «зуб аллигатора», полипэктомические петли, корзины, сетчатые ловушки; биопсийные щипцы не рекомендуются.

Инструменты для извлечения у взрослых

Тип	Инструменты
тупые	щипцы-ретракторы, захваты, полипэктомические петли, корзинки, сетчатые ловушки
остроконечные	щипцы-ретракторы, петли, корзинки, сетчатые ловушки; прозрачный колпачок, латексный конус
длинные	полипэктомические петли, корзинки
пищевые комки	щипцы-ретракторы, захваты, петли, корзинки, сетчатые ловушки

Пищевой комок осторожно низводят в желудок; если это не удаётся, его извлекают целиком или по частям. При значительном сопротивлении проталкивание прекращают.

Эндоскопическое удаление контейнера с наркотиками не рекомендуется: разрыв ведёт к тяжёлой интоксикации и смерти.

При перфорации с флегмоной, медиастинитом, перитонитом изолированное эндоскопическое удаление противопоказано; оно возможно в операционной во время хирургического вмешательства.

Попытки извлечения прекращают при неостанавливаемом кровотечении и если дальнейшие попытки под наркозом увеличивают риск повреждения стенки (рыболовный крючок, проволока «егоза»).

После извлечения обязательно осматривают место фиксации и путь извлечения, оценивают повреждение стенки.

При «свежей» перфорации пищевода (**до 6 часов**) выполняют эндоскопическое клипирование с инсуффляцией углекислого газа. После ушивания целесообразно установить зонд в желудок для питания пациента.

После вклинения пищевого комка или задержки тупого инородного тела необходимо обследовать место задержки для выявления стриктуры, эозинофильного эзофагита, ахалазии, опухоли.

Патология пищевода выявляется более чем у 75% пациентов с вклинением пищевого комка; наиболее часты стриктуры (более 50%) и эозинофильный эзофагит (около 40%).

При подозрении на эозинофильный эзофагит выполняют биопсию из трёх третей пищевода. Стриктуры и кольца Шацкого можно расширить сразу; при повреждении слизистой назначают ингибиторы протонного насоса, а дилатацию проводят через 2–4 недели.

4.4 После удаления

При значительном повреждении слизистой оболочки или глубоком ранении острым предметом выполняют рентгеноскопию с водорастворимым контрастом для исключения перфорации. Поздняя перфорация от пролежня возможна **на 2–5-е сутки**.

Если при травме стенки пищевода с отёком инородное тело не найдено, после противовоспалительной терапии повторяют рентгеноскопию с контрастом и эзофагоскопию, особенно если проглочена рыбья кость.

При выраженном отёке слизистой оболочки пищевода назначают щадящую диету на **3–4 дня** (жидкая, прохладная пища), ибупрофен или парацетамол.

Возможно также применение

1. масляных растворов бета-каротина;
2. облепихового масла;
3. гиалуроновой кислоты;
4. ИПП.

При воспалении, изъязвлениях, трещинах прямой кишки применяют НПВП в суппозиториях.

При значительном повреждении слизистой оболочки или ушитой перфорации назначают короткий курс антибиотиков (цефалоспорины, пенициллины). Даже без перфорации показано наблюдение в стационаре **2–3 дня**.

При операции по поводу перфорации, флегмоны, медиастинита, перитонита антибиотики широкого спектра вводят внутривенно как можно раньше, предпочтительно резервные (карбапенемы).

4.5 Медикаментозная терапия

Ибупрофен: детям до 6 лет по возрасту и массе тела, не более 30 мг/кг в сутки, интервал 6–8 часов

1. 3–6 месяцев: по 50 мг 3 раза в сутки, не более 150 мг в сутки;
2. 6–12 месяцев: по 50 мг 3–4 раза в сутки, не более 200 мг в сутки;
3. 1–3 года: по 100 мг 3 раза в сутки, не более 300 мг в сутки;
4. 4–6 лет: по 150 мг 3 раза в сутки, не более 450 мг в сутки;
5. взрослые и дети старше 6 лет: 200–400 мг 3–4 раза в сутки; не более 800 мг в сутки в 6–12 лет, 1000 мг в 12–17 лет, 1200 мг у взрослых.

Кетопрофен

1. старше 15 лет: внутримышечно 100 мг 1–2 раза в сутки; внутривенно 100–200 мг в 100–150 мл 0,9% раствора натрия хлорида, только в стационаре.

Парацетамол (противопоказан новорождённым)

1. масса тела более 50 кг: 1 г до 4 раз в сутки;
2. масса тела 10–50 кг: 15 мг/кг до 4 раз в сутки;
3. масса тела до 10 кг: 7,5 мг/кг до 4 раз в сутки.

Цефазолин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон: профилактика хирургической инфекции, дозы по инструкции

1. цефотаксим внутримышечно противопоказан детям **до 2,5 лет**;
2. цефтриаксон противопоказан недоношенным детям **до 41 недели**.

Оксациллин, амоксициллин + клавулановая кислота — дозы по инструкции; амоксициллин + клавулановая кислота противопоказан детям **до 2 лет**.

4.6 Хирургическое лечение

Показания к операции

1. инородное тело не удалось извлечь эндоскопически;
2. длительно стоящее в тонкой кишке, не извлекаемое при энтероскопии;
3. перфорация с флегмоной, медиастинитом, перитонитом;
4. тонкокишечная непроходимость;
5. кровотечение, не останавливаемое эндоскопически.

Операцию следует рассмотреть при опасном инородном теле, прошедшем за связку Трейца и не продвигающемся **3 дня**, если эндоскопическое извлечение невозможно. Истинной задержкой видеокапсулы считается её нахождение в тонкой кишке **более 2 недель**.

При контейнерах с наркотиками операция показана при подозрении на нарушение упаковки, отсутствии продвижения, кишечной непроходимости.

Объём операции определяется локализацией инородного тела и осложнениями. Если перфорация пищевода произошла **более 6 часов** назад, как правило, уже развился медиастинит.

Операция при перфорации пищевода

1. торакотомия, медиастинотомия;
2. удаление инородного тела, ушивание пищевода;
3. дренирование средостения и плевральной полости.

Гастростомия показана при технических трудностях ушивания перфорации пищевода, если уже развились гнойно-септические осложнения, в частности гнойный медиастинит.

При перфорации прямой кишки на всю толщину накладывают защитную колостому.

Диаметр пищевода по возрасту

Возраст	Диаметр пищевода
новорождённый	5–6 мм
6 месяцев	8–9 мм
1 год	12 мм
3–6 лет	13–15 мм
15 лет	18–19 мм
взрослый	20–22 мм

Эндоскопы для верхних отделов у детей

Масса ребёнка	Эндоскоп, мм	Канал, мм
новорождённые и младенцы до 10 кг	4,9–5,9	2,0–2,2
от 10 кг	7,8–9,2	2,2–2,8
более 25 кг — стандартные взрослые эндоскопы	9,2–9,9 и более	2,8–3,7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация помощи и госпитализация

При подозрении на инородное тело пищевода в поликлинике выполняют обзорную рентгенограмму шейного отдела пищевода и направляют пациента в стационар с оториноларингологом и эндоскопической службой.

Не рекомендуется

1. вызывать рвоту и «проталкивать» инородное тело жёсткой пищей;
2. промывать пищевод и желудок на дому.

Все пациенты госпитализируются в многопрофильный стационар с круглосуточной эндоскопической службой; при аспирации, перитоните, кишечной непроходимости — в ОРИТ.

При тупом инертном инородном теле до 2–2,5 см без симптомов допустимо амбулаторное наблюдение. После успешного удаления без осложнений и без серьёзного повреждения стенки пациента выписывают сразу.

Показания к госпитализации для наблюдения

1. технически сложное извлечение;
2. несколько предметов, остроконечные, батарейки, магниты, предметы более 5–6 см;
3. обширное повреждение слизистой;
4. травма пищевода 3–5 степени;
5. травма стенки без найденного инородного тела; патология пищевода, имитировавшая инородное тело.

Если острые предметы не извлечены, рентгенографию выполняют ежедневно, при батарейках дистальнее ДПК — каждые 3–4 дня.

При травме стенки пищевода пациента выписывают только после контрольной прицельной рентгенографии органов грудной клетки и эзофагоскопии.

Травмы пищевода (видоизменённая классификация Bassett, 1980)

Степень	Эндоскопическая картина
1	отёк и гиперемия слизистой, обилие слизи (катаральный эзофагит)
2	одиночные царапины, повреждены только верхние слои слизистой
3	значительный отёк, мелкие подслизистые кровоизлияния, скудное кровотечение — повреждена вся толща слизистой
4	слизистая разрушена на значительном протяжении, большие подслизистые гематомы, фибрин, контактная кровоточивость
5	глубокие слепые ранения со слизистой на подслизистый слой, отслойка слизистой 1–2 см, пролежень — повреждён внутренний мышечный слой
6	перфорация, глубокое непроникающее ранение с обильным кровотечением

5.2 Реабилитация и профилактика

После осложнений и операций реабилитацию проводят с учётом осложнения и вида операции; после самостоятельного отхождения или неосложнённого эндоскопического удаления специальная реабилитация, как правило, не нужна.

Родителям следует разъяснять недопустимость оставлять детей без присмотра.

При трихобезоаре необходимо наблюдение психиатра и (или) невролога, ЭГДС **каждые 6–12 месяцев в течение 2–3 лет**.

Необходимо лечить заболевание пищевода, ставшее причиной вклинения пищевого комка (стриктуру, эозинофильный эзофагит, опухоль).

Исход во многом определяется состоянием пищевода (опухоли, ахалазия, дивертикулы, ожоговые стриктуры, эзофагит, врождённая патология); тактика выбирается индивидуально.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Инородное тело в пищеварительном тракте»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 17.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2027 года
Код в рубрикаторе	`710_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация детских хирургов; Российское общество хирургов; Российское общество рентгенологов и радиологов; Эндоскопическое общество «РЭндО»
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки удаления тупых инородных тел желудка 2–2,5–5 см различаются: в таблице 3 (приложение А3) — «отсроченно», то есть в течение 72 часов, в тексте раздела 3 — «в течение 24-48 часов от поступления». На странице приведены оба срока.